Jorge García Badaracco y terapia multifamiliar psicoanálitica.[1]

"En la estructura de la comunidad terapéutica hemos de considerar los distintos elementos que intervienen (médicos, psicólogos, asistentes sociales, enfermeros, pacientes y familiares) y las relaciones interpersonales recíprocas y grupales de todo tipo que se establecen entre los distintos componentes. (…) El concepto de comunidad terapéutica refiere a los factores terapéuticos que posee una comunidad cuando está organizada de tal manera que influye favorablemente en la recuperación mental de sus miembros."

Jorge García Badaracco y Betty Bunge, 1962

Introducción.

Esta cita describe toda una geografía de la salud mental en la Argentina pasada la mitad del siglo XX en la que comenzaban las primeras comunidades terapéuticas, en un ámbito institucional de salud pública y con varios flamantes actores intervinientes como los psicólogos, asistentes sociales y familiares de los pacientes en una nueva mirada horizontal inaugurada por este movimiento.
Para desplegar dicho mapa, se presentará sucintamente cierta coyuntura política, social y disciplinar que incidirá de diversos modos en las lógicas institucionales de los tratamientos familiares.

En el marco de la segunda postguerra mundial y el estado de bienestar, la Argentina, desde 1955 con la destitución de J. D. Perón, hasta 1966 con el golpe de J. C. Onganía, presentó un desarrollismo difuso bajo una secuencia de gobiernos militares y civiles. Allí se dio una cierta renovación intelectual y una creciente radicalización política principalmente en los sectores medios y juveniles. En el plano de la historia intelectual y disciplinar, durante este lapso se produjo una significativa renovación social y cultural, que se extendió a las universidades públicas que, en la segunda mitad de la década de 1950, modernizaron sus planes de estudio y crearon nuevas carreras, entre ellas Psicología en varias provincias. Asimismo, la modernización cultural se expandió a los círculos académicos, en los que se combinaron lecturas psicoanalíticas y marxistas que profundizaron el cruce entre disciplinas "psi"[2] y ciencias sociales.

A partir de esa misma década del cincuenta, se conformó el Movimiento de Salud Mental en la Argentina en consonancia con lo sucedido en Europa y Estados Unidos en la segunda postguerra. Este nuevo modelo, a su vez, se desarrollaba en un clima disciplinar que promovía importantes intercambios entre las ciencias sociales, la psiquiatría y el psicoanálisis, a los que se sumará la psicología desde fines de los cincuenta. Este movimiento se encontraba en plena expansión a partir de los lineamientos que, desde diversas entidades, se ponían en marcha, como el Instituto Nacional de Salud Mental (INSM) en 1957,

[1] Macchioli, F. (2025 en prensa). La familia como comunidad terapéutica. Psicoanálisis y salud mental en Buenos Aires (1957-1984) (francés). Reca M. (Dir.), Jorge Garcia-Badaracco et la thérapie multifamiliale psychanalytique. París: L'harmattan, collection Psychanalyse et civilisations.

[2] Se utilizará el término "psi", entendido como el interjuego móvil entre psiquiatría, psicología y psicoanálisis.

la Federación Argentina de Psiquiatras (FAP) en 1959, la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires (APBA) en 1962, y desde mediados de los cincuenta los servicios de psicopatología de hospitales generales.

En este contexto se produjo una importante extensión del psicoanálisis en la cultura local porteña, así como una proliferación de nuevas técnicas "psi" en las que el grupo pasa a ser el objeto de intervención privilegiado. Este es el escenario en el que se originaron los primeros abordajes familiares, que, cabe subrayar, todos ellos se iniciaron en espacios de gestión pública.[3]

Sin embargo, hacia 1973 el escenario había vuelto a modificarse. El golpe de Onganía de 1966 tuvo importantes consecuencias, tanto para los ámbitos universitarios como para las instituciones públicas, que perdieron parte de su autonomía. Asimismo, a partir del Cordobazo en 1969, se hizo visible un malestar social creciente a la par de una radicalización de las posiciones políticas, que impactaron también en el campo de la Salud Mental. Las luchas sociales fueron primero reprimidas por la triple A y luego por el Terrorismo de Estado I cuál tuvo sus efectos en el campo de las disciplinas "psi" hasta 1983 con el retorno de la democracia. Esta coyuntura promovió la fragmentación y diversificación de distintos grupos e instituciones, que inició principalmente con la primera ruptura de la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA) en 1971 (Carpintero y Vainer, 2005; Vezzetti, 2009).

Ahora bien, este es el contexto sociopolítico y disciplinar en él surgieron losen tratamientos familiares. En una investigación anterior, se sistematizaron cuatro modelos teórico-clínicos para la familia como objeto de intervención "psi" (Macchioli, 2010). El primero, centrado en la familia entendida como *grupo* desde las concepciones y prácticas de Enrique Pichon-Rivière que, en su visión de la familia, planteaba el cruce entre el grupo interno y la dinámica grupal, a partir de un maridaje original entre la tradición de la escuela psicoanalítica inglesa y de la Psicología Social norteamericana (fundamentalmente los aportes de K. Lewin y G. Mead). En segundo lugar, la familia como *sistema*, representado principalmente por Carlos Sluzki quien, además de sus propios desarrollos sobre interacción familiar, tuvo un rol destacado en la recepción y difusión a nivel local de la Teoría de la Comunicación Humana norteamericana, más tarde denominada teoría y técnica sistémica. Tercero, la familia como *estructura*, concebida por Isidoro Berenstein, a partir de la confluencia del psicoanálisis de corte inglés y el estructuralismo francés, principalmente de Levi-Strauss. Por último, la familia entendida como *comunidad*, ideada por Jorge García Badaracco, que planteaba un nuevo dispositivo clínico para la psicosis (fundado en el tratamiento familiar que se inspiró en el modelo inglés de la

[3] Vale aclarar, que muchos de estos profesionales trabajaban *ad honórem* en dichos ámbitos y este compromiso se financiaba por "el consultorio particular de la tarde". El ámbito público, aunque no era lucrativo en modo directo, era un ámbito que además de otorgar prestigio, generaba empleo en el área privada a partir del pedido de supervisiones y de análisis de los jóvenes residentes (Carpintero & Vainer, 2004, p. 85). Cuando aquí se refiera al desplazamiento del ámbito público al privado, en realidad es de ambos ámbitos al exclusivamente privado.

comunidad terapéutica, de Maxwell Jones). A partir de aquí se condensará en la fórmula familia-comunidad.[4]

En el capítulo se trazarán distintos aspectos del último de estos modelos fundamentalmente en el período que va de 1957 con la inauguración del INSM hasta 1984 cuando García Badaracco finalice su segunda presidencia en la APA. Luego se presentará su modelo de Comunidad Terapéutica Psicoanalítica de Estructura Multifamiliar (a partir de aquí CTPEM) y su pasaje a la esfera privada. Finalmente, se expondrán algunos conceptos psicoanalíticos que el psiquiatra argentino debió reformular a la luz de su nuevo abordaje clínico que visibiliza lo distintivo del psicoanálisis porteño de aquellas décadas.

Un psiquiatra poco ortodoxo en los primeros tiempos de la salud mental.

Jorge García Badaracco (1923-2010), se recibió de médico en la Universidad de Buenos Aires en 1947 y viajó a París entre 1950 y 1956 para formarse como psiquiatra y psicoanalista. La biografía profesional de este psiquiatra desde 1957, implica profundizar en la configuración del Movimiento de Salud Mental. Según el horizonte que Pichon-Rivière vaticinaba, "la concepción asilar será reemplazada por la concepción de comunidades terapéuticas." (Zito Lema, 1976, p. 81), y García Badaracco es uno de los primeros en enfrentar el desafío.

En el Hemisferio Norte, en la segunda posguerra se produce una intrincada trama de relaciones interdisciplinares e ideológicas que caracterizan a la psiquiatría internacional y nacional, y que perfilan una nueva configuración de los discursos psi. En esa nueva configuración, el psicoanálisis emerge como matriz explicativa predilecta al refutar y desplazar las teorías de corte naturalista que habían predominado hasta el momento. El surgimiento de la salud mental involucró una serie de circunstancias particulares. El ocaso del positivismo y el despuntar de las ciencias sociales planteaban un nuevo soporte epistemológico para ocuparse de la sociedad. En este contexto, el psicoanálisis, que ya se había incluido dentro de la psiquiatría "dinámica" norteamericana, suministraba una matriz teórica que admitía la articulación de la historia individual a la par de un modelo de causación social. De este modo, la "psiquiatría social" fue uno de los resultados del pasaje de la higiene mental (cuyo auge se dio en la primera posguerra) a la salud mental (inmediata a la segunda posguerra). Este nuevo modelo se ligaba fuertemente a la idea de "libertad", de fuerte impacto durante aquellos años. Desde esta perspectiva, la libertad era el resultado de la

[4] Hasta marzo de 2010 denominé a este modelo "familia múltiple" por ser uno de los modos en que García Badaracco ponía un nuevo acento en el abordaje tanto de la terapia familiar nuclear como de las asambleas multifamiliares. No obstante, poco después preferí asignar la denominación "familia-comunidad" para preponderar la organización comunitaria de la institución en la que coexistían diversos dispositivos, incluidos los familiares y priorizar su filiación con el modelo de la psiquiatría social inglesa de M. Jones. Figuró así por primera vez en: Macchioli, F. "La historia de la terapia familiar en la Argentina en cuatro palabras: el grupo, el sistema, la estructura y la comunidad (1960-1979)". Comunicación libre presentada en el IV Congreso Internacional de Psicoanálisis y Pareja AIPPF, Buenos Aires, 28 al 31 de Julio de 2010. Más tarde se publicó como: Macchioli, F. (2012). Los cuatro conceptos fundamentales: psicoanálisis y terapia familiar en la Argentina (1960-1979). *El sigma*. En: http://www.elsigma.com

elaboración de los conflictos neuróticos y la llegada a la madurez, lo que implicaba a la vez adaptarse y cuestionar al *statu quo*. "Un verdadero cambio de mentalidad, a partir de un método capilar, que iba de abajo hacia arriba" (Dagfal, 2009, p. 77). De esta manera, la psicoterapia sería a partir de entonces definida como instrumento clave de reforma social: ante la gran cantidad de neurosis producto de la educación nociva, la psicoterapia tradicional encerrada en el consultorio debía dar paso a una psicoterapia preventiva y colectiva, que se enlazaba a una nueva educación. En este marco, en 1948 se realiza el Tercer Congreso Internacional de Higiene Mental en Londres, escenario que en realidad incluía tres congresos sucesivos: uno sobre "psiquiatría infantil", en el que participaron Anna Freud y Melanie Klein, otro sobre "psicoterapia médica", y un último sobre "salud mental". Este hecho convirtió al Tercer Congreso Internacional de Higiene Mental en el Primer Congreso Internacional de Salud Mental (Vezzetti, 2016).

Podría decirse que la convergencia de dos modelos, el psicoanálisis psicodinámico y los modelos sociales y grupales, dejan planteados -por lo menos en términos conceptuales- los lineamientos de la renovación psiquiátrica. A partir de aquí puede sostenerse que el proceso de enfermar es grupal, "nadie se enferma solo y, por lo tanto, nadie puede ser curado solo". Los procesos del enfermar pasan a formar parte de una trama de vínculos familiares que conlleva a que la asistencia deba poner en juego el resorte grupal: las terapias familiares y grupales, que a partir de este momento entran en escena.

Desplazando ahora la mirada al sur, pueden establecerse continuidades y discontinuidades entre los modelos heredados de la higiene mental y la salud mental en la Argentina. El dispositivo alrededor de la locura se estableció a nivel local alrededor de 1880 (Vezzetti, 1985). Los higienistas argentinos planeaban reformas sociales preventivas, llevando a cabo dos ampliaciones: el concepto de salud pública, que incorporará los problemas más sensibles para el poder político, y la higiene mental, que validará y añadirá a la psicoterapia como tratamiento eficaz para las enfermedades mentales (Carpintero & Vainer, 2004, 64). En 1929, este movimiento se institucionalizó al crearse la Liga Argentina de Higiene Mental, presidida por Gonzalo Bosch, personaje faro para la psiquiatría local durante las décadas de 1930 y 1940. En 1931 fue nombrado director del Hospicio de las Mercedes[5], cargo en el que se desempeñaría hasta 1947 y desde dónde estimularía, entre otros, a Mauricio Goldenberg y Pichon-Rivière.

Si se tratara de rastrear el pasaje de la higiene mental a la salud mental en la Argentina, sin duda, Gregorio Bermann (1894-1972) y Enrique Pichon-Rivière (1907-1977) son figuras claves en la organización del campo psiquiátrico.

En 1957, año en que se funda el INSM, Pichon-Rivière da su curso sobre *Teoría del vínculo* en la APA. Este libro, publicado recién en 1980, fue interpretado como el pasaje en la obra de Pichon-Rivière de una psiquiatría psicoanalítica a una psicología social. Pero, más allá de que pueda discutirse esta interpretación, dicho libro devino con el tiempo en un símbolo acerca de la importancia que cobraba durante aquel período la intervención sobre los grupos humanos y la sociedad. De ahí en adelante, Pichon-Rivière se transforma en la

[5] Este hospicio cambió varias veces de nombre: en 1863 se denominó originalmente "San Buenaventura", en 1873 pasó a llamarse "Hospicio de las Mercedes" nombre que poseía cuando Pichon-Riviére trabajó allí. Más tarde se denominó Hospital Neuropsiquiátrico de Hombres de Buenos Aires cuando tenía su cargo allí García Badaracco, y actualmente Hospital Interdisciplinario Psicoasistencial "José Tiburcio Borda".

plataforma de todos los desarrollos sobre psicoterapia grupal, institucional y comunitaria de las décadas de 1960 y 1970.

Ya establecido el movimiento de la salud mental, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó en 1953 transformar los hospitales psiquiátricos en comunidades terapéuticas, lo que su cumplió parcialmente en algunos países. Fue en Inglaterra, antes de terminar la Segunda Guerra, donde se gestó primeramente el movimiento de las comunidades terapéuticas a partir de Maxwell Jones (1907-1990), creador de este concepto, aunque ya Wilfred Bion y John Rickman habían realizado experiencias de psicoanálisis grupal previamente. Mas adelante se retomarán los aportes de M. Jones en la Argentina vía García Badaracco.

A nivel local, los cambios que trajo aparejada la segunda posguerra fueron promovidos por un grupo de psiquiatras reformistas que se habían formado en las instituciones asilares, pero que querían modificar ese estado "manicomial" de la psiquiatría local a partir de los nuevos lineamientos de la Salud Mental. Poseían intereses heterogéneos y las disciplinas que abarcaba iban de la reflexología al psicoanálisis. Entre ellos puede ubicarse a Gregorio Bermann, Mauricio Goldenberg, Enrique Pichon-Rivière, Jorge García Badaracco y Guillermo Vidal.

Gracias a este marco regional, y al apoyo de las organizaciones de los países centrales como la OMS y Organización Panamericana de la Salud (OPS), el 11 de Octubre de 1957 se creó el INSM, que reemplazó a la Dirección de Establecimientos Neuropsiquiátricos y a la Dirección de Higiene Mental. Esta institución se inspiró en la reforma del Sistema de Salud inglés de 1954, y en el modelo de Psiquiatría Social norteamericano. De esta manera comenzó "el desarrollo de un proceso que los psiquiatras argentinos promovieron durante declaraciones, reclamos urgentes, asambleas y congresos nacionales" (Vidal, 1958).

El INSM estaba compuesto por dos órganos. El primero correspondía al "Consejo Nacional de Salud Mental", supuestamente compuesto por cinco miembros rentados con funciones técnicas y administrativas, designados por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, el primer equipo solo contó con tres integrantes: Jorge García Badaracco, Mauricio Goldenberg y Raúl Usandivaras, todos ellos comprometidos con la reforma psiquiátrica. El segundo órgano era la "Comisión Nacional Asesora de Salud Mental", conformada por trece miembros honorarios también elegidos por el Poder Ejecutivo y que debían incluir diversas disciplinas como psiquiatría, neurología, psicopedagogía, sociología, derecho y ciencias económicas. En la primera comisión pueden encontrarse nombres como los de Enrique Pichon-Rivière, Telma Reca y Gino Germani (Carpintero & Vainer, 2004, pp. 68, 74).

En este contexto, desde la inauguración del INSM, se crearon jornadas específicas como las Conferencias Nacionales de Salud Mental y publicaciones que acompañaban este escenario como la *Revista Latinoamericana de Psiquiatría* (1951-1954) continuada por el *Acta Neuropsiquiátrica Argentina*, fundada por Guillermo Vidal en 1954.[6] Este órgano se convertiría en el principal

[6] De Octubre de 1954 a 1962 se tituló *Acta Neuropsiquiátrica Argentina*. En 1961 se separó el área neurológica de la psiquiátrica, bautizándose como *Acta Psiquiátrica Argentina* y un año más tarde como *Acta Psiquiátrica y Psicológica Argentina*. A partir de 1964 se denominará finalmente *Acta Psiquiátrica y Psicológica de América Latina* (Weissmann, 1999).

difusor de las reformas en el ámbito de la Salud Mental y en él se publicarían muchos de los aportes en terapia familiar durante las décadas de 1960 y 1970.

Hasta 1957 sólo los psiquiatras se ocupaban de la enfermedad mental a partir de la práctica en los hospicios, situación que generaba descontento sobre esta formación entre los psiquiatras reformistas. En este sentido, una de las primeras obras del INSM fue fundar en la ciudad de Buenos Aires la Residencia de Becarios de Perfeccionamiento con sede en el Hospital Neuropsiquiátrico de Hombres a cargo de Jorge García Badaracco. Dentro del servicio que dirigió se empezaron a realizar las prácticas con el objetivo de generar una formación teórico-práctica integral, con una amplitud que se oponía a la de la Cátedra tradicional del Hospicio. Esta experiencia se prolongó hasta mediados de la década de 1960 pero su avance generaba cada vez mayor oposición por parte de los psiquiatras manicomiales, ya que había fracturado el monopolio de la enseñanza de la antigua Cátedra. A pesar de esta oposición, este programa se mantuvo, y García Badaracco fue diversificando sus intereses en el Hospital. Es así que logró abrir un sector de agudos y crear la primera comunidad terapéutica basada en las ideas de M. Jones. García Badaracco estuvo a cargo de la Residencia hasta 1965 e inauguró el primer Hospital de Día de Latinoamérica. Esto generó desavenencias con el director del hospicio, Omar Ipar, hecho que tras diversos avatares desembocó en la partida de García Badaracco del hospicio.

En este recorrido pueden ubicarse dos etapas en su producción relacionada con la intervención familiar. La primera va de 1961 a 1978 y es en la que escribe todos los trabajos relacionados con los tratamientos familiares en colaboración principalmente con Alfredo Canevaro, Oscar Czertok y Norberto Proverbio, y comparte con ellos también su trabajo clínico en el hospital, en la clínica privada y en la fundación de la Sociedad Argentina de Terapia Familiar (SATF). La segunda etapa parte de 1978 hasta su muerte, en la que figura prácticamente sólo su nombre en artículos y libros. Esta distinción quizás se deba a que el primer período coincide con los trabajos preliminares sobre el abordaje terapéutico familiar, que van incrementándose hacia mediados de la década de 1960 hasta presentar una amplia proliferación hacia 1970, en coincidencia con el Primer Congreso Argentino de Patología y Terapéutica del Grupo Familiar (Buenos Aires, 1970), en el que García Badaracco presenta cuatro trabajos en colaboración. En la segunda etapa, en cambio, quizás sólo figure su nombre por tratarse de un intento de discriminar su abordaje de otros ya consolidados hacia fines de la década de 1970, como los de Isidoro Berenstein y Carlos Sluzki, entre otras figuras. Al mismo tiempo, el segundo período también coincide con la fundación de la SATF, su presidencia en la APA por dos periodos (1980-1984), y en 1991 su postulación como candidato a la presidencia de la International Psychoanalytical Association junto a Horacio Etchegoyen -éste último elegido para presidir la institución de 1993 a 1995 (Sandler, 1991, p. 3). Por tanto, es probable que por sus puestos institucionales de cada vez mayor envergadura, alcanzara un rol protagónico.

Es particularmente llamativo el lugar protagónico que le da a comunidad terapéutica de estructura familiar en su discurso inaugural como presidente de la APA. Analóga a las asociaciones psicoanalíticas a las comunidades organizadas en las que existen subgrupos de estructura multifamiliar. Serían inherentes a la formación psicoanalítica, y “alrededor de cada analista didacta

se estructuran grupos que tienen el carácter de grupos multifamiliares" ubica que algunos aspectos de la patología institucional coinciden con la patología familiar, y sugiere que la institución psicoanalítica desarrolle recursos comunitarios para generar un clima de seguridad psicológica para dirimir los conflictos (García Badaracco, 1981, p. 509). Para llegar a este punto, se desarrollará la conformación de este dispositivo para luego retomar los efectos en el ámbito de la APA.

La familia-comunidad en el dispositivo de la CTPEM. Del hospital público a la clínica privada.

Ahora bien, quien es reconocido internacionalmente como el creador de la terapia familiar múltiple es Henri Peter Laqueur (1909-1979). Desde 1951 había comenzado a atender pacientes esquizofrénicos con terapia familiar múltiple como parte de un programa para establecer una comunidad terapéutica en el Hospital Creedmore State de Nueva York. Primero comenzó con reuniones con los familiares por un lado y los pacientes por otro, una vez por semana. Como esto comenzó a producir ciertas distorsiones y sospechas mutuas entre pacientes y familiares, se decidió reunirlos en un solo grupo durante dos horas, en las que se discutían problemas, además de informar acerca de los tratamientos y evolución de los enfermos. Los grupos eran abiertos a la incorporación de nuevas familias. Esto favorecía que, al estar en diferentes etapas del proceso de cambio, intercambiaban experiencias, se apoyaban mutuamente y mitigaban temores. También se sumaba que la cantidad de terapeutas era insuficiente para atender a la población hospitalaria y este dispositivo introducía mayores cambios en períodos más breves (Simon et al, 1984, pp. 344-395). Problemática que también encontraremos en Argentina.

García Badaracco no cita a Laqueur en sus primeros trabajos sobre el tema ya que no tenía conocimiento de dichas experiencias. Recién lo introduce en su libro *Psicoanálisis multifamiliar* (2000) en el que explica que Laqueur comprobó que algunos pacientes que mejoraron en la internación y sufrían recaídas al reintegrarse a su medio familiar. Para el psiquiatra argentino, Laqueur parte de una premisa diferente a la suya. Aunque ambas experiencias coexistieron durante un período, no coincidían en la metodología. El equipo de García Badaracco más bien observaba la influencia desfavorable que la familia tenía para aquellos pacientes que no habían consolidado el proceso terapéutico. Esto se debía a la articulación entre "la reacción terapéutica negativa, que Freud atribuía a un sentimiento de culpa, y la influencia familiar en la recaída de los pacientes", de las primeras observaciones que lo llevaron a combinar la terapia individual y familiar (García Badaracco, 2000. p. 74).

Recapitulando, García Badaracco implementó diversos espacios institucionales inaugurales en la Argentina. En 1957 ganó el concurso para la jefatura de un servicio en el Hospital Neuropsiquiátrico de Hombres de Buenos Aires, creó en 1958 la primera Residencia en Psiquiatría, en 1962 la primera Comunidad Terapéutica de orientación Psicoanalítica, en 1964 el primer Hospital de Día, y en 1965 finalmente el dispositivo de Comunidad Terapéutica Psicoanalítica de Estructura Multifamiliar.

Si se observa en detalle dicho período, desde 1961 presentó muchas de las ideas rectoras alrededor del rol del psiquiatra dentro del marco que ya para esos años ofrecía la salud mental. Sostuvo que "el trabajo asistencial psiquiátrico está impregnado de enfermedad mental". Para modificar esta situación propuso salir del concepto de "enfermedad" para pasar al de "salud mental", que permite una "actitud operante, constructiva y optimista para el tratamiento de los enfermos" junto a la necesidad de mantener la salud mental del grupo que trabaja con ellos, extendiéndose así el concepto de salud mental al equipo terapéutico (García Badaracco et al, 1961, p. 70).

Las propuestas que planteó en el artículo de 1961 concuerdan con la creación del INSM y la fuerte participación de García Badaracco en este proyecto. En 1958, Goldenberg ya había expuesto su proyecto en el que diagnosticaba una situación hospitalaria precaria e insuficiente para enfrentar diversas necesidades, por lo que proponía nuevos tipos de dispositivos dentro de los hospitales generales, como el uso de la psicofarmacología, las psicoterapias de grupo o las intervenciones comunitarias (Goldenberg, 1983).

Desde esta perspectiva, García Badaracco planteó que si el diagnóstico del médico es pesimista frente a un caso, esta disposición interfiere con una actitud igualmente pesimista que perturba o impide la eficacia terapéutica de un tratamiento. Asimismo, afirmó que en dichas situaciones el médico contempla más "el prestigio personal y la coerción familiar que las posibilidades reales del enfermo" (García Badaracco et al, 1961, p. 70). Según el autor, para no caer en esa posición, era necesario incorporar los factores socioeconómicos, familiares y ambientales, que modifican los grados de salud mental. Desde esta perspectiva, pudo observarse que muchos pacientes iniciaban el proceso de enfermedad a partir de un cambio de contexto (migración externa o interna) donde la separación del ambiente de origen o del núcleo familiar era vivida como una pérdida o surgía una inseguridad ante condiciones nuevas frustrantes (como dificultades para conseguir trabajo o vivienda adecuados), entre otros factores que generaban una situación conflictiva que producía tensión y angustia. Mas adelante, puede articularse esta idea a la de "contexto real del proceso terapéutico" (García Badaracco, 1978b).

En relación al enfermo mental, antes del comienzo aparente de la enfermedad hay "un período más o menos largo caracterizado por la existencia de un comportamiento patológico del enfermo" que es "censurado, castigado o escondido por la familia por desconocimiento y prejuicios acerca de su naturaleza" (García Badaracco et al, 1961, p. 68). Esta situación, que ya había sido descripta por Pichon-Rivière, provoca la segregación del paciente por parte del núcleo familiar, por lo que la primitiva negación de la enfermedad se transforma en lo contrario: la necesidad de internar al enfermo. Estas actitudes llevaron a que se buscara modificar las actitudes de los familiares paralelamente al tratamiento del paciente para impedir que los factores familiares que favorecieron la enfermedad siguieran actuando en la internación, y para que la reinserción al grupo familiar luego del alta fuera exitosa. Así, el médico debía actuar desde el inicio sobre los familiares para obtener colaboración por parte del grupo.

En esta concepción, el medio hospitalario, las condiciones del médico tratante y la estructura del núcleo familiar son partes fundamentales de una *gestalt* necesaria para trabajar adecuadamente (García Badaracco *et al*, 1961, p. 69). Así, el equipo tratante deberá tener en cuenta, para la reinserción del

paciente, la planificación de los siguientes espacios: psicoterapia grupal intensiva, terapia ocupacional para formar al paciente en un oficio acorde a sus posibilidades, conexión con organismos estatales y privados para insertar laboralmente al paciente de un modo estable, y preparación del medio familiar a partir de entrevistas con el médico, el psicólogo y visitas del asistente social al hogar y trabajo. De este modo se observa que incluir a la familia y al ámbito laboral junto al equipo terapéutico es una de las bases fundamentales de esta concepción.

Entre 1960 y 1962 la problemática de la familia advino a la concepción de salud mental local. Pichon-Rivière en 1960 publicó sus primeros artículos sobre psicoterapia del grupo familiar, García Badaracco en 1961 su trabajo sobre psiquiatría y salud mental, Berenstein y Sluzki apenas después, escriben uno sobre la pareja conyugal y el otro sobre la familia en la internación psiquiátrica (Berenstein, 1962; Sluzki, 1963).

García Badaracco trabajó en el neuropsiquiátrico hasta 1968 cuando renunció junto con su equipo tres diversas desavenencias con el director del hospicio, Omar Ipar, director interventor en el marco del gobierno de Onganía (Carpintero y Vainer, 2004, p. 87).

En el mismo año que se va del hospicio fundó la clínica privada "Docencia, Investigación y Tratamiento en Enfermedades Mentales" (DITEM), junto a Alfredo Canevaro y Norberto Proverbio, con quienes trabajaba en el Neuropsiquiátrico. Esta institución reprodujo el dispositivo de la Comunidad Terapéutica Psicoanalítica de Estructura Multifamiliar que se había implementado en el hospicio.

La comunidad para aquel entonces, ya se componía de cuatro estructuras terapéuticas básicas: terapia individual psicoanalítica, terapia grupal comunitaria, terapia del grupo familiar nuclear y grupo familiar múltiple. Dispositivo que se asienta en una comprensión particular del sujeto que parte del psicoanálisis.

García Badaracco sostuvo que fue el psicoanálisis el modelo que aportó la comprensión de los procesos de crecimiento y desarrollo psicoemocional normal del individuo dentro de su contexto familiar. De modo que la psicoterapia de la familia pone de manifiesto la inmadurez intrínseca de la personalidad del paciente pero también de sus familiares, donde se hace necesario un proceso terapéutico familiar para un "redesarrollo" de cada uno de los miembros incluido el paciente. Realiza una crítica al psicoanálisis ortodoxo que desaconsejaba el contacto entre el terapeuta y la familia del paciente suponiendo que perturbaba la relación transferencial. Para García Badaracco esta concepción fue modificada en el campo de la psicosis, donde la inclusión de la familia en el contexto terapéutico permite confrontar los conflictos internalizados por el paciente con los objetos "reales" de su historia familiar (sus padres y hermanos concretos) para realizar experiencias emocionales correctoras de las primitivas relaciones de objeto distorsionantes (García Badaracco. 1989, p. 198).

La idea de transformar el concepto de hospital psiquiátrico en comunidad terapéutica surgen, en parte, por los estudios que muestran los efectos nocivos de la estructura social del hospital mental tradicional en el estado psíquico de los pacientes, donde "la estructura administrativa autoritaria", la "jerarquía rígida", la "estricta división de los grupos profesionales" y el énfasis puesto exclusivamente en la contención de pacientes lleva al sometimiento, la pérdida

de iniciativa y respeto y a una sintomatología artificial tanto para los profesionales como para los pacientes (1989, p. 27).

La comunidad terapéutica se basa en la premisa de que el hospital es un sistema social e intenta utilizar al máximo sus recursos (el personal y la comunidad total del personal) para modificar el comportamiento del paciente para que sea capaz de organizar su vida y relaciones personales constructivamente. Se retoman fundamentalmente los aportes de Maxwell Jones sobre comunidad terapéutica utilizando recursos terapéuticos como la confrontación (lograr que el paciente tome conciencia del efecto de su comportamiento sobre otras personas) o la interpretación de motivaciones (comprender las razones que determinan su conducta). Sin embargo, las confrontaciones solo podrán ser enriquecedoras si el paciente desarrolló recursos yoicos suficientes como para poder afrontarlas.

Los aportes de M. Jones son necesarios, pero no suficientes para García Badaracco. Desde la concepción del psiquiatra inglés no se visualiza suficientemente el camino que recorre cada paciente dentro de la comunidad ni los cambios internos del proceso terapéutico mismo, cuestión que lo lleva a plantear la noción de "Comunidad Terapéutica Psicoanalítica". Esto abre nuevas problemáticas ya que integrar modelos sociológicos y teoría psicoanalítica no resulta sencillo, aunque sea el sino de aquellas décadas. Para García Badaracco la comunidad se comporta como una familia sustitutiva que debe proveer alimento afectivo, estabilidad y modelos de identificación para que el paciente pueda realizar su proceso terapéutico. De este modo la comunidad toma la estructura virtual de una gran familia, materializada técnicamente en lo que llamó "grupo familiar múltiple" (1989, p. 46).

La comunidad terapéutica psicoanalítica funciona como una familia sustitutiva o transicional durante el proceso terapéutico, mientras que la familia "real" se incluye para acompañar este proceso, teniendo en cuenta las propias carencias yoicas de los familiares, condicionadas por las respectivas historias familiares. "Muy a menudo los familiares están poniendo a prueba la posibilidad futura de tratamiento y curación para ellos mismos, a través del tratamiento del enfermo. (…) El médico tiene que poder hacerse cargo potencialmente de toda la familia" (1989, p. 135).

Cabe aquí un paréntesis acerca de a qué llama "real" García Badaracco. Podría ubicarse bastante claramente que desde mediados de los setenta lo usa frecuentemente. En 1978 el primer artículo del primer número de la primera revista de la especialidad en lengua hispana: *Terapia Familiar. Estructura, Patología y Terapéutica del grupo familiar*.[7] es "La familia como contexto real de todo proceso terapéutico" del psiquiatra argentino. Esta curiosa fórmula de "contexto real de la experiencia terapéutica" refiere explícitamente a la familia y al medio social que rodean al enfermo. Este tema lo plantea previamente en 1976 en la presentación "Avances en psicoanálisis de neurosis y psicosis" en el marco del Congreso Latinoamericano de Psicoanálisis (Buenos Aires, 1976) y lo retoma en muchos otros escritos posteriores. Básicamente remite a la idea de "realidad" de Pichon-Rivière. Entre las ideas que maneja el autor de *Teoría del vínculo* acerca de la realidad pueden encontrarse al menos dos predominantes.

[7] Editada por Alfredo Canevaro (miembro del equipo de García Badaracco). El primer número fue publicado en marzo de 1978, simultáneamente en inglés y en castellano. En el consejo de redacción se encontraba García Badaracco.

Una, que el terapeuta explorará la articulación entre mundo interno y mundo externo. Aquí, la confrontación con la realidad permite comprender los alcances y profundidad del malentendido, enfermedad básica del grupo familiar (Pichon-Rivière, 1971, p. 205).

Otra, su concepto de "adaptación activa a la realidad". Ésta es un proceso dialéctico en tanto que el sujeto que se transforma modifica al medio, lo que conlleva una modificación en sí mismo. Esta espiral generará a partir en el proceso terapéutico una mejora que operará simultáneamente en su grupo familiar, produciendo una "desalienación" del intra y extra grupo (Pichon-Rivière, 1971, p. 204).

Recapitulando, en el modelo propuesto por García Badaracco, pueden establecerse algunas reflexiones. Primero, hay un ideal de familia que opera en los terapeutas, en el que se intenta en principio "corregir" y "desarrollar" las carencias familiares, y si esto no es posible "suplir" esas carencias a través del equipo médico y la institución.

Segundo, hay cierta ilusión de cura para la psicosis o neurosis graves a cargo de la familia, y fundamentalmente de un terapeuta que la orienta. De modo tal que si se corrige y completa el desarrollo familiar deficitario puede revertirse la carencia del hijo.

Tercero, dicha ilusión de cura se extiende hacia la familia "real" (el grupo familiar), que, a pesar de aparentar tener capacidades adaptativas idóneas, en realidad posee aspectos inmaduros a nivel emocional y relacional, al igual que el paciente, que evidencian un desarrollo interrumpido.

Cuarto, vale anticipar algo que se retomará al final del capítulo: el pasaje del hospital público al ámbito privado. El ámbito estatal, en el que García Badaracco participó tempranamente y en el cual implementó novedosas experiencias, tanto desde el hospicio como desde el INSM, ofrecía enormes recursos (humanos, técnicos, económicos, científicos, etc.) pero su desventaja radicaba en que estos quedaban supeditados a las políticas de turno.

"Prêt-à-porter". Cuatro conceptos psicoanalíticos rediseñados para la familia-comunidad.

Desde estas directrices se abordarán las diversas operaciones intelectuales que García Badaracco realizó sobre algunos conceptos, mixturando distintas teorías, principalmente las de S. Freud, M. Klein y E. Pichon-Rivière. Estos conceptos se encuentran íntimamente vinculados, por lo que generalmente remitir a uno lleva a tirar de una red compleja en la que emergen todos. Para el objetivo del presente escrito no se profundizará en las acepciones de cada concepto, sino más bien se trabajará en las diversas tramas en los que ellos se entretejen para poner de manifiesto los problemas que guían la operación intelectual de este autor.

Reacción terapéutica negativa. Para el psicoanalista argentino, en la práctica clínica con pacientes psicóticos y sus familiares se observaba mucho más claramente la génesis y estructuración de los procesos internos del sujeto al manifestarse el funcionamiento de los objetos internos "encarnados" afuera, en la familia. La curación o mejoría de los pacientes psicóticos se tornaba muy difícil sin la participación de sus familiares externos en el proceso terapéutico.

Frente a las dificultades propias del enfermo para salir de su enfermedad, se suman las importantes dificultades de su familia que inconscientemente trataba de mantenerlo enfermo. Se observaría en el tratamiento individual del paciente psicótico la reacción terapéutica negativa "producida por la influencia de su grupo familiar" (García Badaracco, 1978a, p. 550).
Para este autor la reacción terapéutica negativa de un paciente no es resultado solamente de una dinámica intrapsíquica particular, sino la consecuencia directa de una acción patógena familiar, a partir de un vínculo previo de "interdependencia patológica" que se estructura en etapas tempranas del desarrollo. Plantea que el trabajo terapéutico sobre la influencia patógena de las figuras parentales permite la neutralización de la influencia familiar convirtiéndose en un aspecto decisivo para resolver la reacción terapéutica negativa. (García Badaracco, 1989, pp. 215-220).
Recapitulando, García Badaracco partía del concepto freudiano, lo cruzaba con los aportes de M. Klein y J. Rivière para complejizar las relaciones objetales del mundo interno y lo ensamblaba finalmente con los aportes argentinos, fundamentalmente de Pichon-Rivière, para tratar ya no a la familia intrapsíquica, sino al grupo familiar (la "familia real" como sostiene García Badaracco), desde la terapia individual, familiar y multifamiliar (Macchioli, 2009a).

Narcisismo familiar. García Badaracco se interesó primero, fundamentalmente, por el narcisismo individual para trabajar la relación transferencial en el vínculo paciente-analista. Es un interés que claramente partía de las dificultades de la clínica, al igual que la reacción terapéutica negativa. Sin embargo, en un segundo momento ubicó este concepto en la estructura misma, ya no sólo del paciente, sino de su familia, una "familia de estructura narcisística". Aquí la psicosis revelaba aspectos no resueltos de por lo menos dos generaciones (padres e hijos). Hacia 1989 queda evidenciada la operación intelectual del cruce del primer Freud, la escuela kleiniana, Pichon-Rivière y Bleger, donde al narcisismo freudiano se le ensamblaban las relaciones narcisistas de objeto, en las que la idealización, la omnipotencia y los objetos parciales deslizan el sentido hacia la simbiosis y aglutinación familiar (García Badaracco, 1989, pp. 199-202).

Interdependencia patológica y patógena. Esta concepción en particular, hizo confluir una infinidad de términos semejantes a una única convergencia, una especie de delta que desemboca en la "interdependencia patológica y patógena", de gran protagonismo desde 1978 en sus escritos. Incluyó ideas de larga data rotuladas de distinto modo según las tradiciones psicoterapéuticas en las que se inscriben: aglutinación, dependencia patológica, ligadura simbiótica, pseudomutualidad, patología vincular, relación simbiótica, simbiosis o vínculo simbiótico. Valen de ejemplo sus palabras:
"las múltiples carencias del paciente psicótico están relacionadas con la dependencia patológica con que vivió siempre sus relaciones dentro del núcleo familiar. El crecimiento, que es un proceso de individuación, incluye desimbiotización, y es atacado por los familiares que temen también los cambios y sienten la separación también como vacío, pérdida y muerte. Atacando los intentos de individuación y desimbiotización, tratan de volver las cosas hacia atrás en un mecanismo de homeostasis patológica. Se puede

entonces observar que el llamado doble vínculo se ejerce para mantener la dependencia y la simbiosis" (García Badaracco, 1978ª, p. 564).
Vale esta cita para ilustrar cierto eclecticismo teórico que permite sofisticar el abordaje de los fenómenos clínicos. Aquí individuación y desimbiotización *versus* dependencia patológica, homeostasis patológica, doble vínculo, dependencia y simbiosis funcionan como equivalencias. Sin embargo, estos términos poseyeron diversos usos y se inscribieron en distintas tradiciones: fundamentalmente los desarrollos sobre dependencia y simbiosis pueden encontrarse primero en el psicoanálisis europeo que se desplazó en la segunda posguerra a Estados Unidos; por otra parte, la homeostasis y el doble vínculo en la tradición norteamericana de la teoría de la comunicación humana.
Tal como sucede con los conceptos anteriores, este conglomerado conceptual entendido por "interdependencia patológica y patógena" se cruza con las ideas de corte pichoneano sobre patología vincular. Los aportes de Pichon-Rivière desde el psicoanálisis ubicaron, asociados a la patología vincular, conceptos como simbiosis, depositario y depositante (García Badaracco, 1979, p. 14). Por otra parte, siguió las concepciones de Bleger sobre autismo y simbiosis respecto a la esquizofrenia. El autor de *Simbiosis y Ambigüedad*, sostuvo que el autismo o esquizofrenia parte de la estructura sincrética, previa a la discriminación. Para Bleger (1966, 1967) el sincretismo pasó a ser una posición más del desarrollo psíquico normal (ubicándola previamente a la posición esquizoparanoide y depresiva kleiniana) y se constituye a su vez en una etapa que atraviesa la familia y el bebé. Si esta etapa se estereotipa surge la patología tanto individual como familiar (García Badaracco, 1989, pp. 208-216).
Podría decirse, sintéticamente, que en esta concepción García Badaracco reúne diversos conceptos de tradiciones heterogéneas: la teoría vincular pichoneana de inspiración psicoanalítica y sus derivaciones (como la de Bleger), los aportes sobre psicosis de la escuela kleiniana, los desarrollos sobre comunicación y esquizofrenia del grupo de Bateson, y sobre esquizofrenia y familia de autores inspirados en el psicoanálisis dinámico norteamericano como L. Wynne o M. Bowen (Macchioli, 2009a).

Complejo de Edipo. Desde la formulación freudiana, García Badaracco planteó que la psicosis se relaciona con las etapas anteriores a la resolución del complejo de Edipo. Para afrontar el complejo se necesitaba previamente haber desarrollado una relación objetal con la madre que permitiera esa preparación. Si la madre no alcanzaba una resolución verdadera de su complejo de Edipo, reactivaría sus propios aspectos no resueltos, estableciendo implícitamente una relación narcisística patológica con su hijo a modo de relación libidinal pregenital que detendría el crecimiento del niño, donde comenzaría a estructurarse la patología psicótica. Así, la relación pregenital del niño estará no solo determinada por la etapa del desarrollo que él mismo atravesaba, sino también por las dificultades propias de la madre para acompañarlo adecuadamente. Quedaría atrapado en un vínculo simbiótico, donde la situación triangular madre-padre-hijo planteaba casi desde el inicio un vínculo de simbiosis patológica madre-hijo, a la par de un padre ausente por estar excluido e imposibilitado para desarticular dicho vínculo.
Cuando en 1979, García Badaracco redefinió el complejo de Edipo, hizo confluir el planteo freudiano con los aportes pichoneanos, diferenciándolos a su

vez, de los aportes estructuralistas de Lévi-Strauss y Lacan. La unión de Freud y Pichon-Rivière le permitió básicamente leer el complejo de Edipo freudiano en clave vincular, al que García Badaracco agregó la lectura intergeneracional: la no resolución del complejo de Edipo en una generación se repetiría en la siguiente.
A diferencia de los conceptos anteriores, aquí se encargó de diferenciarse del estructuralismo. Hace una crítica al modo en que el psicoanálisis interpretó la prohibición del incesto. Para "algunos analistas" el papel del padre era instaurar la separación del hijo respecto a la madre como objeto incestuoso por la prohibición paterna, como Lacan, quien puso el acento en que la resolución del complejo de Edipo era eficaz en tanto instancia prohibitiva que pone un tope a la satisfacción y une inseparablemente deseo y ley. García Badaracco entiende que esta formulación da cuenta de la forma prehistórica en que comenzó la cultura, en coincidencia con Lévi-Strauss, pero no sería el modo en que se produce la elaboración del complejo de Edipo en cada individuo. Sería una premisa falsa suponer que la relación del hijo con la madre era incestuosa porque incluía componentes libidinales propios a toda relación amorosa. La relación primitiva del hijo con la madre es necesariamente simbiótica, narcisista y fusional. Devendría incestuosa cuando el hijo, luego de la sexualización de la pubertad, siga buscando en su madre el objeto sexual sin haber podido canalizar los impulsos eróticos a un objeto exogámico. Cuando la autoridad de los padres es incorporada de un modo protector e introyectada en el yo, contribuye a una fortaleza yoica que permite la elaboración del complejo de Edipo, donde la prohibición se transforma en un renunciamiento al incesto.
Para García Badaracco "padres neuróticos o psicóticos crearán a su vez hijos neuróticos o psicóticos y por lo tanto el complejo de Edipo de los niños refleja con toda transparencia el complejo de Edipo no resuelto de los propios padres" (García Badaracco & Zemborain, 1979, p. 85). De algún modo, aquí se dibuja el escenario opuesto al freudiano. Si antes la determinación provenía del mundo pulsional y el modo en que elaboraba las fases libidinales el niño, ahora la determinación provenía de los padres hacia el niño y el modo en que ellos la elaboraron en sus infancias (Macchioli, 2009b).

La familia-comunidad se gana un lugar.

Luego del recorrido propuesto, se retomarán ciertas tramas que dibujan escenarios complejos, imbricados y móviles que dan lugar a la emergencia de lo que aquí denomino familia-comunidad.

Por una parte, no puede perderse de vista el escenario de las disciplinas "psi" en la Argentina. Desde mediados de los cincuenta, al fundarse las carreras de Psicología en varias provincias, se abre el juego de una serie de disputas disciplinares entre la psiquiatría, el psicoanálisis y la psicología durante las siguientes décadas que aquí llamamos "psi" para condensar esas luchas de campo disciplinar. En este escenario, el abordaje familiar fue un buen estímulo para la inserción de los psicólogos. Así como los primeros profesionales que se ocuparon de la cuestión fueron predominantemente psiquiatras-psicoanalistas (Pichon-Rivière, García Badaracco y Berenstein; no así Sluzki, aunque su ubicación por fuera del psicoanálisis no lo eximiera de compartir ámbitos de

formación y atención con psicoanalistas), posteriormente los psicólogos prácticamente igualaron las posiciones de prestigio dentro de la especialidad (Macchioli, 2014).

Por otra parte, vale atender al interjuego entre instituciones públicas y privadas. El ámbito estatal, en el que García Badaracco participó tempranamente y en el cual implementó novedosas experiencias, tanto desde el hospicio como desde el INSM, ofrecía enormes recursos (humanos, técnicos, económicos, científicos, etc.) pero su desventaja radicaba en que estos quedaban supeditados a las políticas de turno. En esta dirección, puede observarse que la entrada y salida del ámbito público de García Badaracco estaba en sintonía con los tiempos políticos argentinos: su inserción en 1957 luego de la caída del peronismo y en el umbral del gobierno de Frondizi marcaba tiempos de una renovación no sólo social y política, sino también disciplinar. Del mismo modo, su partida en 1968, después de "La noche de los bastones largos" y antes del Cordobazo, enmarcado en el gobierno de Onganía, marcaba el fin de una época que en el ámbito de las disciplinas "psi" se advertiría desde 1966. Las necesidades disciplinares pasaban, desde fines de la década de 1950, a poner el acento en la modernización social, en la que Pichon-Rivière representó la punta de lanza y el movimiento de la salud mental su bandera, para pasar a mediados de la década de 1960 a una politización creciente del ámbito disciplinar que culminaría a mediados de la década siguiente con el golpe de Estado de 1976. García Badaracco fue uno de los protagonistas del primer momento, y prefirió tomar distancia del segundo replegándose a los ámbitos privados al igual que muchos otros profesionales. En 1968 García Badaracco y su equipo inauguraron DITEM y junto con Canevaro, en 1978 inauguraron dos proyectos también privados: la revista *Terapia familiar* y la SATF. A su vez, preside otra institución privada, la APA, de 1980 a 1984 (prácticamente todo el período bajo el contexto de dictadura militar). Allí, como se detalló previamente, analoga a las asociaciones psicoanalíticas a las comunidades terapéuticas multifamiliares (García Badaracco, 1981, p. 509) e instala al interior de una institución bastante reticente a todo aquello que no sea intrapsíquico el funcionamiento de grupos multifamiliares.
Todo lo expuesto condujo, entre otras cuestiones, a que la heterogeneidad de ideas y experiencias que se daban en el cruce entre psicoanálisis y ciencias sociales en ámbitos públicos y privados se perdiera, en gran medida, al desplazarse solo al ámbito privado básicamente entre 1968 y 1976. Este repliegue interrumpió paulatinamente las vías de comunicación e intercambio profesional. Y, a pesar de que otorgó cierta libertad en el modo de seleccionar a los miembros y llevar adelante las prácticas, cercenó la afluencia de recursos técnicos y humanos hospitalarios (considerando la cantidad y el tipo de población que acudía) que confería el ámbito público. Al mismo tiempo este proceso preservó a los profesionales para continuar con su labor clínica con familias y los "encerró" en instituciones privadas que cada vez se fortificarían más, hasta entablar diálogos predominantemente endogámicos. Esta situación favoreció el desarrollo paralelo, a nivel local, de los modelos de familia-sistema, familia-estructura y familia-comunidad. Los cruces que se daban hacia 1970 que promovían un diálogo posible en un espacio en común, se harían cada vez más esporádicos hasta casi desaparecer en la década siguiente. La familia-comunidad siguió funcionando en clínicas psiquiátricas, hasta su

reincorporación en algunos espacios públicos durante la década del noventa, con grupos multifamiliares en los Hospitales Neuropsiquiátricos J. T. Borda y B. Moyano. Recién en 2008 se organizaría el primer congreso sobre psicoanálisis multifamiliar (Macchioli, 2014).

Es interesante revisar cómo el viejo problema de la psicosis para la psiquiatría al articularla, luego de la segunda postguerra, con aportes más contemporáneos como los de la psiquiatría social que trae aparejado el dispositivo de comunidad terapéutica reincorpora nuevamente a la familia ya no sólo como problema sino como recurso. Amplía el foco del individuo al grupo y establece una enfermedad que más que orgánica e intrapsíquica se desplaza al eje comunicacional, interaccional y social, que no niega la del enfermo pero la reubica en un segundo plano.

Bibliografía.

- Berenstein, I. (1962). La pareja conyugal. Vínculos, roles y niveles de comunicación. *Acta Psiquiátrica y Psicológica de América Latina*, 8(2), 105-110.
- Carpintero, E. & Vainer, A. (2004). *Las huellas de la memoria. Psicoanálisis y Salud Mental en la Argentina de los '60 y '70. Tomo I: 1957-1969.* Buenos Aires: Topía.
- Carpintero, E. & Vainer, A. (2005). *Las huellas de la memoria. Psicoanálisis y Salud Mental en la Argentina de los '60 y '70. Tomo II: 1970-1983*. Buenos Aires: Topía.
- Dagfal, A. (2009). *Entre París y Buenos Aires. La invención del psicólogo (1942-1966).* Buenos Aires: Paidós.
- Garcia Badaracco, J. (1978a). Integración del psicoanálisis individual y la terapia familiar en el proceso terapéutico del paciente psicótico. *Revista de Psicoanálisis*, 35 (3), 529-578.
- García Badaracco, J. (1978b). La familia como contexto real de todo proceso terapéutico. *Terapia Familiar*, Año 1 (1), 9-16.
- García Badaracco, J. (1989). *Comunidad Terapéutica Psicoanalítica de Estruc Multifamiliar*. Madrid: Tecnipublicaciones.
- García Badaracco, J. (2000). *Psicoanálisis Multifamiliar. Los otros en nosotros descubrimiento del sí mismo*. Buenos Aires: Paidós.
- García Badaracco, J. (2002). Comentario sobre el trabajo de Enrique Pich Rivière: "Neurosis y psicosis: una teoría de la enfermedad". *Revista Psicoanálisis,* 59(4), 891-898.
- García Badaracco, J. y Bunge, B. (1962). El problema de la actitud psicoterápica la asistencia psiquiátrica. *Acta Psiquiátrica y Psicológica Argentina*, Vol. 8, 289-2
- Garcia Badaracco, J., Montevecchio, B. & De Kossoy, I. (1961). Trabajo psiquiát y salud mental. *Acta Neuropsiquiátrica Argentina*, Vol. 7 (1), 67-70.
- Goldenberg, M. (1983). "Relato de mi más querida experiencia docente-asistencial" Clase dictada en Noviembre de 1982. En Hornstein, L. (1983). *Introducción al psicoanálisis*. Buenos Aires: Trieb.
- Jones, M. (1952). *Social psychiatry: a study of therapeutic communities*. London: Tavistock Publications.
- Jones, M. (1953). The *Therapeutic Community; a New Treatment Method in*

Psychiatry. London: Basic Books,
- Laqueur, H.P. y LaBurt, H.A. The therapeutic community on a modern insulin ward. *Journal of neuropsychiatric*, 3, 139-149, 1962.
- Macchioli, F. (2009a). La psicosis en la familia: modelo para armar. Jorge García Badaracco y la versión de algunos conceptos psicoanalíticos (1960-1979). En *Actas de las Primeras Jornadas de Historia, Psicoanálisis y Filosofía*, Vol. 1, Año 2009, CD ROM. También en: http://www.elseminario.com.ar/
- Macchioli, F. (2009b). "El complejo de Edipo es producto de la influencia familiar". Aportes de Jorge García Badaracco para una historia de la terapia familiar en la Argentina (1960-1979). *Memorias del I Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología, XVI Jornadas de Investigación*, 420-423.
- Macchioli, F. (2010). Los inicios de la Terapia Familiar en la Argentina. Implantación, configuración y desarrollo de un nuevo campo disciplinar. 1960-1979. Disertación doctoral no publicada, Facultad de Medicina, UBA, 2010.
- Macchioli, F. (2012). Los cuatro conceptos fundamentales: psicoanálisis y terapia familiar en la Argentina (1960-1979). *El sigma*. ISSN-e: 2027-064XEn: http://www.elsigma.com
- Macchioli, F. (2014). El surgimiento de los tratamientos familiares en la Argentina: ámbitos públicos, ámbitos privados y disciplinas "psi". En Dossier "Historias de la psicoterapia infantil y los tratamientos familiares en la Argentina", Revista *Generaciones*, pp. 179-194.
- Pichon-Rivière, E. (1971). *Del Psicoanálisis a la Psicología Social*, Tomo II, Buenos Aires: Editorial Galerna.
- Sandler, J. (1991). Presidential message: Joseph Sandler. IPA Newsletter, 22(3). Recuperado el 03 de julio de 2024, https://www.ipa.world/ipa/Images/PDFDocuments/IPA-News-Magazine/ipa-newsmag-1992-sum.pdf
- Sluzki, C. (1963). El grupo familiar del paciente internado. *Acta Psiquiátrica y Psicológica de América Latina*, 9(4), 304-326.
- Vezzetti, H. (1985). *La locura en la Argentina*. Buenos Aires: Paidós.
- Vezzetti, H. (2009). Psicanálise e marxismo: a fratura da Associação Psicanalítica Argentina em 1971 [Traducción de Pinheiro Filho, F. A.]. *Tempo Social*, Revista del Departamento de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, 21(2), 61-85.
- Vezzetti, H. (2016). *Psiquiatría, psicoanálisis y cultura comunista*. Buenos Aires, Siglo XXI.
- Vidal, G. (1958). Editorial. *Acta Neuropsiquiátrica Argentina*, 1959, 5, 3.
- Weissman, P. (1999). *Cuarenta y cinco años de psiquiatría argentina desde las páginas de Acta*. Mar del Plata: Universidad Nacional de Mar del Plata.
- Zito Lema, V. (1976/1985). *Conversaciones con Enrique Pichon Rivière sobre el arte y la locura.* Buenos Aires, Ediciones Cinco.